Panduan lansia ZMC

Nyeri badan lansia: sendi, lutut, pinggang, dan kapan tidak boleh ditunda

Nyeri saat berdiri, berjalan, atau bangun dari duduk? Cek polanya dulu, lalu rawat dengan aman.

Tidak semua nyeri lansia adalah asam urat atau pegal biasa. Bila nyeri datang setelah jatuh, sendi merah-panas disertai demam, atau kaki mendadak lemah, periksa hari itu juga.

Cek gerak
Apakah nyeri mengubah cara jalan atau berdiri?

Cek radang
Ada panas, merah, bengkak, atau demam?

Rawat aman
Jangan diam total, tetapi juga jangan memaksa.

1) Ringkasan cepat: nyeri lansia yang sering ditemui

Nyeri badan pada lansia paling sering berasal dari otot dan sendi, terutama lutut, pinggang bawah, leher-bahu, atau kaki. Pola ini sering terkait osteoartritis, otot yang melemah, terlalu lama diam, posisi tubuh, riwayat jatuh, atau berat badan berlebih. Namun beberapa nyeri bisa menandakan infeksi, saraf terjepit, patah tulang, atau penyakit lain yang tidak aman ditunggu.

Yang paling penting: jangan langsung menyimpulkan semua nyeri sebagai **asam urat**, jangan tirah baring total berhari-hari, dan jangan memijat area yang sedang panas-merah-bengkak atau nyeri hebat setelah jatuh.

Biasanya masih cocok dengan nyeri muskuloskeletal

- Lebih terasa saat mulai bergerak, naik tangga, berdiri lama, atau setelah aktivitas.
- Membaik sebagian dengan istirahat singkat, kompres, dan gerak bertahap.
- Lokasinya di sendi atau otot tertentu, bukan seluruh tubuh dengan gejala berat lain.

Perlu dipikirkan penyebab lain

- Nyeri baru pertama kali terasa sangat berat atau cepat memburuk.
- Ada kebas, kesemutan, atau rasa kaki seperti tidak kuat menopang.
- Nyeri datang bersama bengkak besar, demam, atau berat badan turun tanpa sebab jelas.

Kapan evaluasi medis: bila nyeri menetap lebih dari 2 sampai 4 minggu, mengganggu tidur, mengubah cara berjalan, atau membuat aktivitas harian seperti salat berdiri, mandi, dan naik turun tempat tidur jadi jauh lebih sulit.

Orientasi cepat area nyeri yang sering mengganggu gerak pada lansia. Nama area utama tetap dibaca di label dan poin teks di sekitar gambar.

Lebih sakit saat berdiri
Sering mengarah ke lutut, panggul, atau punggung bawah.

Kaku saat bangun pagi
Biasanya membaik setelah mulai bergerak pelan.

Nyeri malam yang tidak biasa
Bila menetap atau makin berat, jangan hanya rawat sendiri.

2) Cek cepat di rumah sebelum memutuskan rawat sendiri

Bagian ini dibuat supaya pasien dan keluarga bisa cepat membaca pola nyeri. Kalau dari cek awal sudah tampak tidak biasa, lebih aman konsultasi daripada menunda.

Di mana letak nyerinya?
Nyeri di satu sendi besar seperti lutut atau bahu berbeda pendekatannya dengan nyeri menjalar dari pinggang sampai kaki. Nyeri betis yang bengkak sepihak juga bukan pola pegal biasa.

Ada bengkak, merah, panas, atau demam?
Kalau iya, pikirkan radang aktif atau infeksi. Sendi yang sangat panas-merah disertai demam tidak aman hanya dioles atau dipijat.

Apakah cara jalan berubah?
Kalau sampai pincang berat, tidak kuat menapak, atau perlu pegangan mendadak, ini tanda fungsi gerak mulai terganggu dan perlu dinilai.

Ada kebas, kesemutan, atau kaki terasa lemah?
Gejala saraf seperti ini lebih serius daripada nyeri otot biasa, terutama bila muncul mendadak atau disertai sulit kencing atau menahan BAB.

Jika hasil cek masih cocok untuk rawat rumah

- Nyeri masih bisa ditahan dan tidak terus memburuk cepat.
- Tidak ada demam, tidak ada trauma berat, dan tidak ada lemah mendadak.
- Masih bisa bergerak pelan meski terasa kaku atau ngilu.

Jika hasil cek sudah meragukan

- Nyeri baru pertama kali terasa sangat berat.
- Area sakit tampak berubah bentuk, bengkak besar, atau tidak bisa digerakkan.
- Nyeri terasa terus walau sedang istirahat atau tidur malam.

> **Kapan evaluasi medis:** kalau keluarga melihat perubahan gerak, postur, atau keseimbangan yang jelas dibanding biasanya, jangan menunggu sampai jatuh dulu baru periksa.

3) Langkah aman di rumah: jangan diam total, jangan juga memaksa

Rawat rumah yang aman biasanya bertujuan mengurangi nyeri, menjaga gerak, dan mencegah kaku makin berat. Prinsipnya bertahap, terukur, dan tidak asal coba semua cara sekaligus.

Tetap bergerak sedikit-sedikit

Hindari tiduran terus lebih dari 1 sampai 2 hari, kecuali dokter memang menyuruh. Jalan santai di rumah, pindah posisi, dan peregangan ringan biasanya lebih membantu daripada diam total.

Praktisnya: bangun tiap 30 sampai 60 menit, lakukan 3 sampai 5 menit gerak ringan, lalu istirahat lagi.

Kompres dingin bila baru cedera atau bengkak

Kompres dingin cocok bila area baru memerah, bengkak, terasa berdenyut, atau habis terkilir. Bungkus es dengan kain, tempel 10 sampai 15 menit, jangan langsung ke kulit.

Kompres hangat bila kaku otot atau nyeri lama

Kompres hangat lebih cocok untuk otot tegang, pegal lama, atau sendi yang kaku saat mulai bergerak. Gunakan 10 sampai 15 menit, hangat saja, jangan terlalu panas.

Atur posisi tidur dan duduk

Untuk pinggang bawah, bantal kecil di bawah lutut saat telentang atau bantal di antara lutut saat miring bisa membantu. Saat duduk, kaki menapak penuh dan jangan membungkuk lama.

Atur aktivitas harian dengan pola "sedikit tapi rutin"

1. Pecah pekerjaan rumah menjadi bagian kecil. Misalnya sapu 5 menit, duduk sebentar, lalu lanjut lagi.
2. Jangan sekaligus angkat barang berat, mengepel lama, atau naik turun tangga berulang bila nyeri sedang kambuh.
3. Pakai alas kaki yang pas dan tidak licin. Sandal tipis yang mudah lepas justru menambah risiko jatuh.

Yang sebaiknya dihindari: pijat keras pada area yang sedang panas-merah-bengkak, membungkuk sambil memutar badan saat mengangkat beban, dan minum obat nyeri berhari-hari tanpa tahu kondisi lambung, ginjal, atau tekanan darah.

Bila keluhan mulai membaik: pertahankan gerak ringan harian. Targetnya bukan langsung kuat seperti dulu, tetapi tetap aman, tetap mandiri, dan tidak makin kaku.

Kapan evaluasi medis: bila 2 sampai 3 hari rawat rumah tidak memberi perbaikan, atau nyeri justru bertambah, bangun dari kursi makin sulit, atau keluarga harus terus menopang saat berjalan.

4) Latihan ringan yang realistis dan aman untuk dilakukan di rumah

WHO menganjurkan lansia tetap aktif, termasuk latihan kekuatan dan keseimbangan. Untuk pasien nyeri, mulainya tidak perlu lama. Yang penting aman, konsisten, dan berhenti bila muncul nyeri tajam, sesak, atau pusing berat.

Bangun-duduk dari kursi -

Latihan ini membantu otot paha, bokong, dan keseimbangan saat pindah posisi.

- Pakai kursi kokoh yang tidak mudah bergeser.
- Duduk tegak, kaki menapak, lalu berdiri pelan. Kalau perlu, mulai dengan bantuan tangan.
- Ulang 5 sampai 8 kali. Istirahat bila lutut atau pinggang terasa terlalu berat.

Penguatan paha depan saat duduk +

Cocok untuk nyeri lutut ringan sampai sedang.

- Duduk di kursi, luruskan satu lutut perlahan sampai hampir sejajar.
- Tahan 3 sampai 5 detik, turunkan pelan, lalu ganti sisi.
- Mulai 6 sampai 10 kali per kaki.

Gerak pergelangan kaki dan betis +

Baik untuk sirkulasi dan kekakuan setelah lama duduk.

- Putar pergelangan kaki pelan ke kanan dan kiri saat duduk.
- Bisa juga jinjit sambil berpegangan pada meja atau sandaran kursi.
- Lakukan 8 sampai 10 kali dengan napas tetap tenang.

Peregangan bahu dan punggung ringan +

Cocok untuk kaku leher-bahu atau punggung akibat posisi duduk lama.

- Angkat dan turunkan bahu perlahan.
- Tarik bahu ke belakang, tahan sebentar, lalu rileks.
- Jangan memutar leher mendadak atau membungkuk dalam saat nyeri sedang tajam.

Latihan keseimbangan dengan pegangan +

Bagian ini penting karena CDC menekankan pencegahan jatuh pada lansia.

- Berdiri sambil memegang meja atau sandaran kursi yang stabil.
- Coba tahan berdiri dengan kaki sedikit rapat selama beberapa detik.
- Kalau sudah aman, lanjut jalan di tempat pelan-pelan. Selalu ada orang di dekat bila keseimbangan belum mantap.

Gambar ini hanya orientasi visual. Urutan gerak, jumlah ulangan, dan tanda berhenti tetap dibaca di accordion latihan.

Kapan evaluasi medis: bila latihan ringan selalu memicu nyeri yang makin menjalar, lutut terasa mau copot, atau setelah latihan justru muncul bengkak besar dan jalan makin berat.

5) Obat nyeri: yang relatif aman dan yang perlu hati-hati pada lansia

Tujuan obat adalah membantu pasien kembali bergerak lebih nyaman, bukan membuat pasien asal menahan nyeri sambil tetap memaksa aktivitas. Pada lansia, keputusan obat harus lebih hati-hati karena banyak yang juga punya hipertensi, sakit lambung, ginjal, jantung, diabetes, atau obat rutin lain.

Yang relatif lebih aman sebagai langkah awal

- **Obat oles/topikal** sering lebih aman untuk nyeri sendi lokal karena efek ke seluruh tubuh biasanya lebih kecil dibanding obat minum.
- **Parasetamol** kadang dipakai sebagai pereda nyeri ringan, tetapi tetap harus memperhatikan batas aman dan kondisi hati. Jangan minum rangkap dari beberapa produk sekaligus.

Yang perlu lebih hati-hati

- Obat anti-nyeri golongan antiinflamasi minum dapat memperberat masalah lambung, ginjal, tekanan darah, dan jantung pada sebagian pasien.
- Obat tidur atau obat yang membuat mengantuk bisa meningkatkan risiko jatuh bila dipakai sembarangan.
- Kalau sedang minum pengencer darah, obat nyeri tidak boleh dipilih asal-asalan.

Tanyakan dulu ke dokter bila ada

- Riwayat sakit lambung atau muntah darah.
- Penyakit ginjal, jantung, atau bengkak kaki karena gagal jantung.
- Tekanan darah tinggi yang belum stabil.

Jangan hanya mengandalkan obat

- Kalau terus minum obat tanpa memperbaiki gerak, berat badan, dan risiko jatuh, nyeri biasanya akan mudah kambuh.
- Nyeri yang selalu kembali juga bisa berarti diagnosis awal belum tepat.

Segera kontrol obat bila

- Setelah minum obat muncul nyeri ulu hati hebat, BAB hitam, muntah, pusing berat, atau lemas.
- Pasien jadi sangat mengantuk, bingung, atau jalannya makin goyah.

Pesan aman: bawa daftar semua obat rutin saat kontrol, termasuk jamu, suplemen, atau obat warung. Banyak interaksi obat pada lansia baru ketahuan setelah riwayatnya dibaca lengkap.

6) Cegah jatuh di rumah: bagian ini sama pentingnya dengan mengurangi nyeri

CDC menekankan bahwa jatuh pada lansia bisa berujung pada patah tulang, rawat inap, dan hilangnya kemandirian. Kalau nyeri sudah membuat langkah berubah, bagian pencegahan jatuh tidak boleh dilewatkan.

Pencahayaan dan jalur jalan

Terangi jalur ke kamar mandi, singkirkan kabel dan barang berserakan, dan hindari lantai licin. Karpet kecil yang mudah geser lebih baik disingkirkan.

Bangun perlahan

Setelah bangun tidur, duduk dulu di tepi kasur 1 sampai 2 menit sebelum berdiri. Ini membantu mencegah pusing mendadak.

Sepatu dan alat bantu

Pakai alas kaki yang pas dan tidak licin. Kalau memang perlu tongkat atau alat bantu jalan, gunakan sesuai ukuran dan jangan malu memakainya.

Cek obat, mata, dan telinga

Obat yang bikin mengantuk, penglihatan yang buram, dan pendengaran yang menurun bisa ikut meningkatkan risiko jatuh.

Orientasi ruang rumah yang lebih aman: lampu cukup, jalur jalan lega, dan area kamar mandi perlu perhatian khusus.

Checklist cepat: lampu malam menyala, kamar mandi ada pegangan, sandal tidak licin, barang di lantai disingkirkan, dan ada keluarga yang tahu bila pasien mulai sering hampir jatuh.

Kapan evaluasi medis: bila sudah beberapa kali hampir jatuh, jatuh berulang, atau pasien makin takut berjalan karena merasa tidak seimbang.

7) Kondisi khusus yang tidak boleh dianggap sama dengan pegal biasa

Pada lansia dengan penyakit penyerta, ambang untuk periksa memang harus lebih rendah. Nyeri yang tampak ringan di luar bisa jauh lebih bermakna bila ada osteoporosis, diabetes, stroke, penyakit ginjal, atau jantung.

Osteoporosis atau riwayat patah tulang

Kalau nyeri muncul setelah jatuh kecil atau setelah salah gerak lalu sangat sulit berdiri, pikirkan kemungkinan cedera tulang. Ini terutama penting pada pinggul, tulang belakang, dan pergelangan tangan.

Diabetes atau gangguan saraf

Keluhan kebas, baal, atau luka kaki yang tidak terasa bisa berjalan bersama nyeri. Pemeriksaan kaki dan alas kaki jadi lebih penting.

Penyakit ginjal atau jantung

Pemilihan obat nyeri harus lebih hati-hati. Bengkak kaki, sesak, atau berkurangnya kencing perlu dinilai terpisah dan jangan dianggap hanya karena nyeri sendi.

Riwayat stroke atau kelemahan satu sisi

Latihan tetap penting, tetapi perlu lebih terarah karena nyeri bisa muncul akibat pola jalan yang berubah atau bahu yang kurang stabil.

Penggunaan steroid lama atau kanker

Kalau ada nyeri tulang/punggung yang baru dan terus-menerus, jangan ditunda. Ada kondisi yang perlu evaluasi lebih cepat daripada nyeri otot biasa.

Kelemahan berat, nafsu makan turun, atau berat badan turun

Ini sinyal bahwa masalahnya bisa lebih dari sekadar sendi aus atau otot tegang. Evaluasi langsung lebih aman.

Bawa saat kontrol: daftar obat rutin, hasil lab terakhir kalau ada, catatan kapan nyeri mulai, riwayat jatuh, dan foto area bengkak bila saat datang ke klinik bengkaknya sudah berkurang.

8) Kapan harus ke dokter hari ini dan kapan harus ke IGD

Ini bagian terpenting untuk keselamatan. Kalau ada salah satu tanda di bawah, jangan puas hanya dengan kompres atau obat warung.

Ke IGD segera bila nyeri muncul setelah jatuh dan pasien tidak bisa berdiri atau menapak, ada kelemahan atau baal mendadak, gangguan BAK atau BAB yang baru, sesak atau nyeri dada, kebingungan, atau nyeri punggung berat disertai demam tinggi dan tubuh sangat lemas.

Periksa hari ini atau secepatnya

- Sendi merah, panas, bengkak, apalagi bila ada demam.
- Nyeri baru pertama kali sangat hebat atau cepat memburuk.
- Nyeri membuat jalan berubah jelas atau perlu bantuan mendadak.
- Nyeri malam terus-menerus sampai tidak bisa tidur.

Tidak aman ditunggu

- Kaki atau tangan mendadak lemah.
- Tidak bisa menahan kencing atau BAB, atau sulit kencing baru muncul bersama nyeri punggung.
- Area nyeri tampak berubah bentuk setelah jatuh.
- Betis bengkak satu sisi, merah, terasa hangat, atau kaki jadi pucat dan dingin.

Kontrol terjadwal tetapi jangan terlalu lama

- Nyeri menetap lebih dari 2 sampai 4 minggu.
- Bangun dari kursi, naik tangga, atau salat berdiri makin sulit dari minggu ke minggu.
- Obat oles dan rawat rumah hanya membantu sebentar lalu cepat kambuh lagi.

Kalau ragu: lebih aman periksa. Pada lansia, keterlambatan evaluasi bisa berujung jatuh, dehidrasi, rawat inap, atau hilangnya kemampuan bergerak mandiri.

9) FAQ singkat

Pertanyaan ini sering muncul di rumah. Jawabannya dibuat singkat supaya cepat dipakai, tetapi kalau kondisi pasien tidak cocok dengan pola umum ini, tetap perlu evaluasi langsung.

Kalau nyeri sudah beberapa bulan, apakah berarti pasti asam urat? +

Tidak. Pada lansia, nyeri menahun lebih sering berkaitan dengan osteoartritis, otot melemah, pola gerak, atau punggung bawah. Asam urat hanya salah satu kemungkinan dan biasanya punya pola tersendiri.

Lebih baik istirahat total atau tetap jalan? +

Untuk sebagian besar nyeri muskuloskeletal, tetap bergerak pelan jauh lebih baik daripada tirah baring total berhari-hari. Yang dihindari adalah aktivitas berat, gerakan memaksa, dan berjalan tanpa alat bantu padahal keseimbangan sedang buruk.

Kompres hangat atau dingin yang benar? +

Dingin lebih cocok untuk bengkak baru atau cedera baru. Hangat lebih cocok untuk kaku otot dan nyeri lama. Kalau ada panas-merah-bengkak yang curiga radang atau infeksi, jangan langsung pakai hangat dan jangan dipijat.

Boleh pijat supaya cepat enakan? +

Boleh sangat hati-hati hanya pada pegal otot ringan yang tidak bengkak, tidak panas, dan tidak habis jatuh. Kalau nyeri berat, ada bengkak, panas, kemerahan, atau bentuk sendi berubah, jangan dipijat.

Kalau sudah pakai tongkat, apa berarti kondisi sudah parah? +

Tidak selalu. Alat bantu justru bisa menjaga keamanan dan mengurangi beban pada sendi. Yang penting ukurannya pas dan cara pakainya benar.

10) Rujukan resmi

Halaman ini disusun dari sumber resmi yang dicek ulang pada 11 Maret 2026. Rujukan ini membantu menjaga isi tetap selaras dengan anjuran terbaru, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan langsung.

1. WHO. Physical activity. Dicek ulang 11 Maret 2026. Dipakai untuk dasar anjuran aktivitas fisik lansia, termasuk latihan penguatan dan keseimbangan.
2. CDC. About Older Adult Fall Prevention. Dicek ulang 11 Maret 2026. Dasar risiko jatuh, dampak jatuh pada lansia, dan komponen pencegahan jatuh.
3. NIAMS. Osteoarthritis. Dicek ulang 11 Maret 2026. Dasar gejala OA, sendi yang sering terkena, dan pendekatan umum penanganan.
4. NIAMS. Back Pain. Dicek ulang 11 Maret 2026. Dipakai untuk penjelasan nyeri punggung bawah dan kapan perlu evaluasi medis.
5. MedlinePlus. Back Pain. Dicek ulang 11 Maret 2026. Dipakai sebagai pelengkap red flags dan kapan menghubungi tenaga kesehatan.
6. Kemenkes RI Ayo Sehat. Osteoarthritis. Dicek ulang 11 Maret 2026. Dipakai untuk konteks lokal mengenai osteoartritis dan pesan edukasi pasien.
7. Kemenkes RI Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjut Usia. Portal Keslan Kemenkes RI. Dicek ulang 11 Maret 2026. Dipakai untuk materi lansia, aktivitas aman, dan pencegahan risiko jatuh pada usia lanjut.

> Konten ini untuk edukasi pasien dan keluarga. Diagnosis pasti, pilihan obat, evaluasi patah tulang, infeksi sendi, gangguan saraf, atau penyesuaian latihan tetap perlu konsultasi langsung.

Print / Save PDF

Simpan halaman ini bila ingin dibuka offline atau dibawa saat kontrol. Untuk menghubungi klinik, gunakan tombol WhatsApp dan Instagram di hero atau tautan footer.

Zihan Medical Center

#ZMCGakNyuekinKamu - layanan 24 jam untuk keluarga Wanaraja dan sekitarnya.

Jl. Kudang, Wanajaya, Wanaraja, Wanajaya, Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44183

Telepon: +62 822-1718-0432

Jam: Senin - Minggu: 24 Jam

Kontak dan lokasi

WhatsApp

Maps

Instagram

Tip offline: simpan file ini satu folder dengan `../zmc-logo.jpeg` agar logo tetap tampil saat dibuka langsung dari perangkat.

© 2026 Zihan Medical Center - Wanaraja Garut

Materi edukasi pasien. Bukan pengganti pemeriksaan langsung.